

NS 22231567737 / 429

ISRAEL ELEOTERIO DA SILVA

IDADE: 38 PESO: 72 ALTURA: 183 PROFISSÃO: Eng. Mec. - Alunus

SINTOMAS: Ronca / Sonoência

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: não.

nega HAS / DM / edema de mm II.

MÉDICO: Dr. Salinas

EXERCÍCIO FÍSICO: muito. 2x / 2x bola futebol.

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 4:20

COCHILLO (X)SIM ()NÃO 30' DORME ACOMPANHADO ()SIM ()NÃO (X)EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA (X)NÃO

FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 0x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: -

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH: 381

SPO2: 79%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N)NASAL (X)AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (N)ENDÓCRINA ()CARDÍACA

(S)ORTOPÉDICA ()NEUROLÓGICA ()OUTROS

↳ escoliose (operou 18a).

16/08/23 P= 4-10 cmH₂O22/08/23 P= 7.0 cmH₂O

Bem adaptado

IAH= 2.8 e/ev

Fuga= 6hr.

m. de uso: 6hr

fua

05/08
23P= 7.0 cmH₂O

ajusto.

IAH= 3.5 e/ev

m. de uso: 6h 10'

Bem adaptado, relata sonoência.

fua

27/08
24P= 7.0 cmH₂O

TROCO filtro

IAH= 4.0 e/ev

m. de uso: 6hr

Relata que o peso

fua

11/11
24P= 7.4 cmH₂O

Bem adaptado.

IAH= 4.9 e/ev

↑ P= 7.8 e/ev

m. de uso= 6hr

fuga= 9.3 e/ev

fua

05/02
25P= 7.8 cmH₂O

↓ Tempo Roupa.

IAH= 2.9 e/ev

m. de uso: 5h 43'

fua

23/07
25P= 7.8 cmH₂O

fuga= 4.

m. de uso: 7h 10'

IAH= 0.9 e/ev

fua



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificado em Medicina do Sono
Especialidade em Distúrbios do Sono
Mestre em Psiquiatria pela UNESP
Atualizado em 14/04/2022
CRM-SP: 69730

DR. ELITÂNIA MARINHO
Medicina do Sono
Certificado em Distúrbios do Sono
CRM-SP: 62858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Israel Eleutério da Silva

EXAME nº: 5096

SOLICITADO POR: Dr. Carlos Henrique Labinas de Oliveira

DATA: 25/03/2022

IDADE: 36 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h00min e concluído às 06h14min. A latência para o sono foi de 18 minutos e a latência para o estágio REM, de 220 minutos. O tempo total de sono foi de 405 minutos (06h45min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 81,9%. A distribuição do sono mostrou 21,9% de estágio 1, 58,5% de estágio 2, 10,4% de estágio 3 e 9,3% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 71,5 minutos em vigília, ocorreram 240 microdespertares (índice: 35,6/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 67,7/hora, sendo 30,8 apneia/hora e 36,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 68/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 94% e a mínima de 83%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (67,7/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (68/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 46; máxima: 67 bpm.

O ronco foi contínuo e médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 18 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (220 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 81,9%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 35,6/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (21,9%; normal: 8-10%) e 2 (58,5%; normal: 45-55%), e a redução do estágio REM (9,3%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 3 (10,4%; normal: 10-12%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 17 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

clínica
DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
CRM-SP 62.858

LAUDO DA PSIQUIATRIA POLISSONOGRAMA

NOME: Israel Eleutério da Silva
EXAME nº: 5096-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Carlos Henrique Labinas de Oliveira
DATA: 29/06/2022
IDADE: 37 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h23min e concluído às 06h09min. A latência para o sono foi de 13 minutos e a latência para o estágio REM, de 161 minutos. O tempo total de sono foi de 309 minutos (05h09min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 77,2%. A distribuição do sono mostrou 15,4% de estágio 1, 65,4% de estágio 2, 3,1% de estágio 3 e 16,2% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 78,5 minutos em vigília, ocorreram 120 microdespertares (índice: 23,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 38,1/hora, sendo 19,4 apneia/hora e 18,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 38,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 97%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 79%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 8,8 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (38,1/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (38,1/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 50; máxima: 70 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 13 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (161 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 77,2%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 23,3/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (15,4%; normal: 8-10%) e 2 (65,4%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (3,1%; normal: 10-12%) e REM (16,2%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Diretor Técnico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



**Labinas
Ranna
e Arrais**
clínica médica

**Dr. Carlos Henrique
Labinas de Oliveira**
Otorrinolaringologista
CRM/SP 67.843
RQE nº 17.731

**Dr. Cesar Augusto
Ranna Araújo**
Endocrinologista
CRM/SP 62.911
RQE nº 17.257

**Dra. Claudia
Arrais Araújo**
Pediatra
CRM/SP 62.912
AMIB 104267

**Telma Lúcia Paludeto
Parizzi de Oliveira**
Fonoaudióloga
CRFª/SP 5.623

ISRAEL ELEUTERIO DA SILVA

Encaminho o paciente acima para adaptação e uso de CPAP

HD SAHOS

Comentários:

São José dos Campos, 25 de agosto de 2022

Dr. Carlos Henrique Labinas de Oliveira

CRM 67843



@labinasrannaearraais

www.labinasrannaearraais.com.br

Av Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 335 - Ed. Madison Tower, sala 501
Jardim Aquarius - São José dos Campos - SP
[12] 3941-8191 / 3922-0365 / 3941-8518
CEP: 12246-000